

Kan/Doku Eozinofilisi (Eozinofilik GİS)

Periferik ve/veya gastrointestinal doku eozinofilisi saptanan çocukta sekonder nedenleri (parazit, ilaç, atopi, GÖRH, İBH, primer immün yetmezlik, HES/malignite) dışlamaya; eozinofilik özofajit (EoE) ve non-EoE eozinofilik GİS hastalıklarını (EGID) endoskopi/biyopsi eşikleriyle tanımaya; PPI, yutulan topikal steroid ve eliminasyon diyetini dozunda uygulamaya yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Sekonder eozinofili dışlama

EoE ≥ 15 eoz/BBA

PPI · topikal steroid

Eliminasyon diyeti

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Eozinofili iki ayrı düzlemde değerlendirilir: **periferik kan eozinofilisi** ve **doku (GİS mukoza) eozinofilisi**. Kan eozinofilisi mutlak eozinofil sayısı ($AEC = \text{lökosit} \times \% \text{eozinofil}$) ile derecelendirilir: hafif $500-1500/\mu\text{L}$, orta $1500-5000/\mu\text{L}$, ağır $>5000/\mu\text{L}$; en az bir ay arayla iki ölçümde $AEC >1500/\mu\text{L}$ veya belirgin doku infiltrasyonu **hipereozinofili** olarak adlandırılır. GİS'te doku eozinofilisi normalde özofagusta bulunmaz (özofagus mukozasında eozinofil **her zaman patolojiktir**), buna karşın mide/ince bağırsak/kolonda fizyolojik olarak değişken sayıda eozinofil vardır — bu nedenle non-EoE EGID tanısı bölgeye özgü eşiklere dayanır. Klinik görevin özü: (1) eozinofilinin **primer (eozinofilik GİS hastalığı)** mı yoksa **sekonder (başka bir hastalığa reaktif)** mı olduğunu ayırmak; (2) GİS semptomu olan çocukta uygun düzeylerden yeterli sayıda biyopsi alarak EoE ve non-EoE EGID'yi eşiklerle tanımlamak; (3) tedaviyi (PPI, yutulan topikal steroid, diyet) histolojik remisyon hedefine göre yönetmek. Kritik kavram: EoE artık "PPI'ye yanıtlosigkeit" ile tanımlanmaz — PPI bir tanı testi değil, **tedavi seçeneğidir** (AGREE 2018); tanı, özofagus disfonksiyon semptomu + biyopside pik ≥ 15 eoz/BBA + diğer nedenlerin dışlanmasına dayanır.

$AEC = \text{lökosit} \times \% \text{eozinofil}$

Hafif $0.5-1.5$ · Orta $1.5-5$ · Ağır >5 ($\times 10^9/\text{L}$)

Hipereozinofili: $>1500 \times 2$ / doku

Özofagusta eozinofil daima patolojik

EoE = semptom + ≥ 15 eoz/BBA + dışlama

PPI tanı testi değil, tedavidir

Öyküde sorgula

- Özofageal disfonksiyon: disfaji, katı lokması takılması/impaksiyon, yavaş yeme, çiğneme-yutma ritüelleri, göğüs/epigastrik ağrı, kusma, reflü benzeri yakınmalar; küçük çocukta beslenme reddi, kusma, büyüme geriliği
- Non-EoE EGID: kronik karın ağrısı, bulantı-kusma, erken doyma, ishal, protein kaybettiren enteropati (ödem), asit; kanlı dışkı ve süt çocuğunda alerjik proktokolit
- Atopi yükü: astım, alerjik rinit, atopik dermatit, IgE aracılı besin alerjisi, mevsimsel alevlenme; ailede atopi/EoE öyküsü
- Sekonder ipuçları: yakın zamanda başlanan **ilaçlar** (DRESS: antikonvülzan, sülfonamid, minosiklin), seyahat/kırsal maruziyet, çığ et-toprak teması (**parazit**), gelişimsel gerilik/tekrarlayan enfeksiyon (primer immün yetmezlik)
- Sistemik/kırmızı bayrak: kilo kaybı, gece terlemesi, ateş, döküntü, lenfadenopati, kanama, kemik ağrısı (malignite/HES); kardiyak-nörolojik semptomlar (organ hasarı)
- Diyet öyküsü ve önceki PPI/steroid denemeleri, tetikleyici besinler, eliminasyon deneyimleri

Muayenede deęerlendir

- B y me antropometrisi ve persentil seyri; boy hızı d ş   /kilo kaybı (kronik EoE ve EGID'de beslenme yetersizlięi)
- Beslenme-hidrasyon: solukluk (anemi),  dem (hipoalbuminemi/protein kaybettiren enteropati), kas k tlesi kaybı
- Batın: distansiyon, hassasiyet, hepatosplenomegali, asit (eozinofilik serozit), kitle
- Atopik zemin: egzama, alerjik shiners, kronik rinit-astım bulguları
- Cilt-lenfatik: yaygın d k nt  + ate  + LAP (DRESS), yaygın LAP/organomegali (hematolojik hastalık), pete i-purpura
- Sistemik hipereozinofili organ hasarı: kardiyak  f r m/yetmezlik bulgusu, n rolojik defisit, tromboembolik i aretler

Kavram: "Eozinofili var" tanı deęildir;  nce sorulacak soru "bu primer eozinofilik bir G S hastalıęı mı, yoksa ba ka bir s rece reaktif sekonder eozinofili mi?" olmalıdır.  zofagus biyopsisinde eozinofil g r lmesi her zaman anormaldir, ancak ≥ 15 eoz/BBA e ięi +  zofageal disfonksiyon semptomu + dięer nedenlerin dı lanması olmadan "EoE" denmez.

Eozinofili primer eozinofilik GİS hastalıklarından (EoE ve non-EoE EGID) çok sayıda sekonder nedene kadar geniş bir yelpazede yer alır. Klinik yaklaşımın omurgası, tedaviye başlamadan önce sekonder ve sistemik nedenlerin dışlanmasıdır — çünkü tedavi (özellikle steroid), altta yatan paraziti, immün yetmezliği veya maligniteyi maskeleyebilir ya da kötüleştirebilir. Aşağıdaki kategoriler ayırıcı tanının çatısını oluşturur.

Eozinofilik özofajit (EoE) — Th2 mekanizma

- Kronik, antijen (çoğunlukla besin) aracılı, Th2/IL-5/IL-13 baskın immün hastalık; özofagusa lokalize eozinofilik inflamasyon
- Semptom (özofageal disfonksiyon) + pik ≥ 15 eoz/BBA + diğer nedenlerin dışlanması ile tanı (AGREE 2018)
- Tedavisiz seyrinde fibrozis-striktür-lümen daralması; erkeklerde ve atopiklerde sık

Non-EoE EGID (gastrit/enterit/kolit)

- Eozinofilik gastrit, enterit, kolit; mukozal, muskuler veya seroz (asit) tutulum paternleri
- Bölgeye özgü histolojik eşikler gerekir (özofagustan farklı; mide/bağırsakta bazal eozinofil vardır)
- Süt çocuğunun besin proteini ilişkili alerjik proktokoliti bu spektrumun hafif ucudur

Sekonder — parazit ve enfeksiyon

- Helminthler: **Strongyloides** (immünsüpresyon öncesi mutlaka dışla), Toxocara, Ascaris, kancalı kurt, Trichinella, Schistosoma
- Dışkı O&P (3 örnek) + serolojiler; eozinofili + GİS semptomu olan her çocukta önceliklidir
- Steroidten önce Strongyloides dışlanması yaşamsaldır (hiperinfeksiyon riski)

Sekonder — ilaç, atopi, GÖRH

- İlaç reaksiyonu/**DRESS**: antikonvülzanlar, sülfonamidler, minosiklin, allopurinol, NSAİ; döküntü-ateş-LAP-eozinofili
- IgE aracılı besin alerjisi, atopik hastalık yükü kan eozinofilisini yükseltir
- GÖRH ve diğer özofajit nedenleri özofagusta düşük düzey eozinofili yapabilir; EoE ile ayrımı biyopsi düzeyi ve klinik bağlamla

Sekonder — İBH, bağ dokusu, immün yetmezlik

- İnflamatuvar bağırsak hastalığı (özellikle Crohn) doku eozinofilisiyle seyredebilir; kalprotektin/endoskopi ayırır
- Bağ dokusu/vaskülit (EGPA), otoimmün enteropati
- Primer immün yetmezlik: **IPEX**, Omenn, hiper-IgE (STAT3/DOCK8); erken başlangıç, ekzema, enteropati, enfeksiyon üçlüsü

Sistemik — HES, malignite, endokrin

- Hipereozinofilik sendrom (HES): AEC >1500 kalıcı + organ hasarı; miyeloproliferatif (PDGFR/FGFR/JAK2), lenfositik veya idiyopatik
- Malignite: lösemi, lenfoma (özellikle T-hücreli/Hodgkin) reaktif eozinofili yapar — kilo kaybı, LAP, sitopeni
- Adrenal yetmezlik eozinofiliyi artırır; nadir konjenital immün-disregülasyon sendromları

Eşik kuralı: Özofagus: pik ≥ 15 eoz/BBA ($\sim \times 400$) EoE için gereklidir. Non-EoE EGID için önerilen eşikler bölgeye göredir — eozinofilik gastrit: ≥ 30 eoz/BBA (≥ 5 alanda); eozinofilik enterit (duodenum): ≥ 50 -52 eoz/BBA; eozinofilik kolit: segmente göre değişir (sağ kolon normalde daha yüksek). Bu eşikler klinik bağlam ve sekonder nedenlerin dışlanmasıyla birlikte yorumlanır.

03 Karar akışı

İlk çatal, tablonun periferik kan eozinofilisi ağırlıklı mı yoksa aktif GİS semptom/bulgusuyla mı seyrettiğidir; bu, sistemik/sekonder tarama ile endoskopik-histolojik değerlendirme yollarını ayırır. İkinci çatal, özofageal disfonksiyon semptomu ile birlikte biyopside pik ≥ 15 eoz/BBA saptanıp saptanmadığı ve diğer nedenlerin dışlanıp dışlanmadığıdır. Amaç: primer EoE/EGID'yi doğru tanımlamak, sekonder ve tehlikeli nedenleri (HES, malignite, immün yetmezlik, Strongyloides) atlamamak ve steroide başlamadan önce paraziti dışlamaktır.

BAŞLANGIÇ

Kan ve/veya doku eozinofilisi saptandı

AEC'yi hesapla ve derecelendir (hafif/orta/ağır). İlaç, seyahat/parazit, atopi ve sistemik (kilo kaybı, ateş, LAP) öyküsünü tara. Doku örneği varsa bölge ve pik eozinofil sayısını not et.

ADIM 1

Kaynağı ve baskın tabloyu ayır

Tam kan sayımı-formül, dışkı O&P + Strongyloides serolojisi, IgE, ilaç gözden geçirmesi; GİS semptomu varsa endoskopik yolu planla. Kalıcı/ağır eozinofilide organ hasarı taraması ekle.

KARAR 1

Baskın tablo izole periferik eozinofili mi, aktif GİS semptomu/bulgusu mu?

İzole/ağır periferik eozinofili sistemik-hematolojik yolu; özofageal disfonksiyon veya kronik GİS semptomu ise endoskopik-histolojik yolu tetikler.

İZOLE/AĞIR KAN EOZİNOFİLİSİ → Sistemik tarama

GİS SEMPTOMU VAR → Endoskopi

DIŞLA

Sekonder + HES/malignite taraması

Parazit, ilaç (DRESS), atopi dışla; AEC >1500 kalıcı ise organ hasarı (troponin/EKO, periferik yayma, LDH, triptaz, ferritin) + hematoloji değerlendirmesi. Organ hasarı/atipik hücre → HES/malignite yolunda ilerle.

İNCELE

EGD $\pm$ kolonoskopi + çok düzeyli biyopsi

Sekonder nedenler (parazit, ilaç) dışlanırken üst endoskopi; özofagustan en az iki düzeyden ≥ 6 biyopsi, ayrıca mide-duodenum ve gerekirse kolon örnekleme. Endoskopi normal görünse de biyopsi al.

KARAR 2

Özofageal disfonksiyon semptomu + pik ≥ 15 eoz/BBA + diğer nedenler dışlandı mı?

EoE tanısının üç bileşeni. Diğer nedenler (parazit, ilaç, İBH, sistemik) dışlanmış olmalı; PPI yanıtı artık tanı ölçütü değildir (tedavi seçeneğidir).

EVET → EoE tanısı

TANI

EoE → tedaviyi başlat (PPI / topikal steroid / diyet)

Üç tedavi kolundan biriyle başla, hedef histolojik remisyon (<15 eoz/BBA); 8-12 haftada endoskopi ile yeniden değerlendir. Striktür varsa dilatasyon eklenebilir.

HAYIR → EoE dışı

YENİDEN SINIFLA

Non-EoE EGID veya sekonder nedeni doğrula

Mide/bağırsak/kolon biyopsilerini bölgeye özgü eşiklerle değerlendir (EoG ≥ 30 , duodenum ≥ 50 eoz/BBA); eşik altıysa parazit, İBH, ilaç, immün yetmezlik ve sistemik nedene yönel. Tanısız/atipik ise hematoloji ile birlikte HES/malignite dışla.

Not: Sistemik/yutulan steroide başlamadan önce **Strongyloides mutlaka dışlanmalıdır**

(immünsüpresyon altında hiperinfeksiyon-dissemine hastalık riski). Kilo kaybı, ateş, LAP, sitopeni, atipik periferik hücreler veya organ hasarı bulguları varlığında endoskopiye odaklanmadan önce hematolojik-onkolojik değerlendirme önceliklidir.

Tetkik, eozinofilinin derecesini ve baskın tabloyu belirlemekle başlar; sekonder ve tehlikeli nedenleri (parazit, ilaç, İBH, HES, malignite) dışlarken GİS semptomu olan çocukta çok düzeyli endoskopik biyopsiye ilerler. Histolojik eşikler bölgeye özgüdür ve klinik bağlamla yorumlanır.

Kan/doku eozinofilisinde kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Dereceyi belirle	Tam kan sayımı + periferik formül; AEC hesabı	Hafif 0.5-1.5 · Orta 1.5-5 · Ağır >5 ($\times 10^9/L$); >1500 kalıcıysa hipereozinofili yolu
Basamak 2 · Parazit dışla	Dışkı O&P (3 örnek) + Strongyloides serolojisi ($\pm$ Toxocara)	Steroidten önce zorunlu ; hiperinfeksiyon riski; kırsal/seyahat öyküsünde genişlet
Basamak 3 · İlaç ve atopi	İlaç gözden geçirmesi (DRESS taraması), total/spesifik IgE, atopi öyküsü	Yeni başlanan antikonvülzan-sülfonamid-minosiklin sorgula; atopi kan eozinofilisini artırır
Basamak 4 · Sistemik/inflamatuvar	CRP, sedim, albümin, fekal kalprotektin, TTG-IgA + total IgA, karaciğer-böbrek fonksiyon	İBH, protein kaybettiren enteropati, çölyak ve sistemik hastalık taraması
Basamak 5 · Üst endoskopi + biyopsi	EGD; özofagustan ≥ 2 düzeyden en az 6 biyopsi + mide + duodenum örnekleri	EoE: pik ≥ 15 eoz/BBA; endoskopi normal görünse de biyopsi al; EREFS skorla
Basamak 6 · Alt endoskopi (endike ise)	Kolonoskopi + segmental biyopsiler (ileum dahil)	İshal/kanlı dışkı/kolit şüphesinde; EoG ≥ 30 · duodenum ≥ 50 eoz/BBA, kolon segmente göre
Basamak 7 · Hipereozinofili/organ hasarı	Troponin + EKO/EKG, periferik yayma, LDH,	AEC >1500 kalıcı veya organ bulgusu; PDGFRA/B, FGFR1,

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
	B12, triptaz, ferritin; hematoloji konsültasyonu	JAK2 füzyon/mutasyon taraması
Ek · İmmün yetmezlik (seçili)	İmmünglobulinler, lenfosit alt grupları, gerektiğinde genetik (IPEX/FOXP3, STAT3, DOCK8)	Erken başlangıç, ekzema, kronik enfeksiyon, otoimmün enteropati üçlüsünde
İzlem · Tedavi yanıtı	Tedavi/diyet değişikliğinden 8-12 hafta sonra kontrol endoskopi + biyopsi	Histolojik remisyon hedefi <15 eoz/BBA; semptom ve EREFS ile birlikte değerlendir

Sıralama ilkesi: Önce eozinofilinin derecesini belirle ve parazit-ilaç-sistemik nedeni dışla; GİS semptomu olan çocukta endoskopiye normal görünümde bile biyopsiyle tamamla (özofagus için ≥ 2 düzey, ≥ 6 örnek). Kalıcı/ağır periferik eozinofili veya organ hasarı bulgusunda hematolojik-onkolojik değerlendirmeyi geciktirme.

Aşağıdakiler; tablonun primer eozinofilik GİS hastalığından çok tehlikeli/sistemik bir sürece (HES, malignite, immün yetmezlik, dissemine parazit) işaret ettiğini veya acil müdahale gerektiğini düşündürür.

- Ağır/kalıcı hipereozinofili ($AEC > 5000 \times 10^9/L$ veya > 1500 iki ölçümde) — HES/hematolojik hastalık

- Kardiyak tutulum: troponin yüksekliği, kalp yetmezliği-üfürüm, aritmi, tromboembolik olay (eozinofilik miyokardit — acil)

- Nörolojik bulgu, açıklanamayan tromboemboli veya çok organ hasarı (sistemik eozinofilik hastalık)

- Konstitüsyonel bulgular: kilo kaybı, gece terlemesi, uzamış ateş, yaygın lenfadenopati, organomegali (lenfoma/lösemi)

- Sitopeniler, periferik yaymada atipik/blast hücreler, belirgin LDH yüksekliği

- Döküntü + ateş + LAP + transaminaz yüksekliği + eozinofili (DRESS) — ilacı kes, sistemik değerlendir

- Özofageal katı besin impaksiyonu/akut disfaji — acil endoskopik çıkarım; altta EoE araştır

- Protein kaybettiren enteropati: yaygın ödem, ağır hipoalbuminemi, asit (eozinofilik serozit)

- Steroid planlanan çocukta dışlanmamış Strongyloides riski (kırsal/endemik maruziyet) — hiperinfeksiyon tehlikesi

- Erken başlangıç + tedaviye dirençli enteropati + ekzema + kronik enfeksiyon (IPEX/primer immün yetmezlik)

EoE tedavisinin üç ana kolu ("3 D") vardır: **Drug** (PPI, yutulan topikal kortikosteroid, biyolojik), **Diet** (eliminasyon) ve **Dilatasyon** (fibrostenotik striktür). Sekonder eozinofilide öncelik altta yatan nedenin (parazit tedavisi, ilaç kesilmesi, İBH tedavisi) yönetimidir; sistemik hipereozinofili/HES hematoloji ile ortak yürütülür. Aşağıdaki dozlar başlangıç değerleridir; ağırlık, yaş, yanıt ve histolojik remisyona (<15 eoz/BBA) göre bireyselleştirilir. Tedavi/diyet değişikliğinden 8-12 hafta sonra kontrol endoskopi-biyopsi standarttır. EoE kroniktir; yanıt alınan kolda idame tedavisi gerekir.

Eozinofilik GİS hastalığında tedavi ve dozlar

TEDAVİ / İLAÇ	DOZ
Proton pompa inhibitörü (PPI)	Omeprazol/esomeprazol 1-2 mg/kg/doz, günde 2 ke
Yutulan flutikazon (topikal STC)	Ölçülü doz inhaler, yutularak: <10 yaş 88-440 µg ×2
Yutulan budesonid (oral viskoz/orodispersibl)	<10 yaş (veya <150 cm) 1 mg/gün; ≥10 yaş 2 mg/gü

TEDAVİ / İLAÇ	DOZ
Eliminasyon diyeti — ampirik	Basamaklı: 2-besin (süt+buğday/gluten) → 4-besin
Eliminasyon diyeti — elementer	Aminoasit bazlı formül; oral kalori gereksiniminin t
Tek-besin (süt) eliminasyonu	Yalnız inek sütü proteini eliminasyonu, 8-12 hafta

TEDAVİ / İLAÇ	DOZ
Dupilumab (biyolojik, dirençli EoE)	Kilo bandına göre SC: ≥ 15 -<30 kg 200 mg/2 hafta; ≥ 30 kg 300 mg/2 hafta
Özofageal dilatasyon	Endoskopik dilatasyon (kademeli); tıbbi tedaviyle b
Sekonder eozinofili — nedene yönelik	Parazitte antihelmintik (ör. albendazol/ivermektin);
HES/sistemik (hematoloji ile)	Organ hasarında sistemik prednizolon 1-2 mg/kg/g

Yaklaşım: EoE'de üç koldan (PPI, yutulan topikal steroid, eliminasyon diyeti) hasta/aile tercihi ve fenotipe göre birini seç; 8-12 haftada endoskopi-biyopsi ile histolojik remisyonu (<15 eoz/BBA) doğrula; yanıt alınan kolda idameyi sürdür. Diyetle tetikleyicileri yeniden yükleme ile bireyselleştir. Sekonder eozinofilide asıl tedavi altta yatan nedendir.

Dikkat: Sistemik veya yutulan steroide başlamadan önce **Strongyloides** ve diğer parazitleri dışla (hiperinfeksiyon riski). Tedaviyi yalnızca semptomla değil, kontrol biyopsisiyle değerlendir — semptomatik düzelme histolojik remisyon anlamına gelmez. Ağır/kalıcı hipereozinofili veya organ hasarı varlığında endoskopiye odaklanmadan önce hematolojik-onkolojik değerlendirme yap; kardiyak tutulum acildir.

Yönetim; sekonder nedeni dışlamaya, primer EoE/EGID'yi histolojik olarak tanımlamaya, seçilen tedavi kolunda remisyonu belgelemeye ve kronik hastalıkta idame + büyüme-uyum izlemine dayanır. İzlemin omurgası; semptomların gerilemesi, kontrol biyopsisinde <15 eoz/BBA remisyonu, büyümenin korunması ve komplikasyonların (striktür, beslenme yetersizliği) önlenmesidir.

İzlem ve takip

- Tedavi/diyet değişikliğinden 8-12 hafta sonra kontrol endoskopi + biyopsi; histolojik remisyon (<15 eoz/BBA) hedefi
- Semptom, EREFS endoskopik skoru ve histolojiyi birlikte değerlendir; semptomsuz aktif inflamasyon olabilir
- Büyüme-persentil, beslenme durumu ve diyet altında mikronutrient takibi (özellikle çok-besin eliminasyonunda kalsiyum/D vitamini, protein)
- Eliminasyon diyetinde tek tek yeniden yükleme ile tetikleyici besinleri belirle; her yükleme sonrası endoskopik doğrulama
- Yanıt alınan kolda idame tedavisi; en düşük etkili doza titrasyon, periyodik histolojik kontrol
- Kalıcı/sistemik eozinofili ile hematoloji ile ortak izlem; organ hasarı parametrelerinin (kardiyak) periyodik takibi

Yönetim ve güvenlik ağı

- Steroid öncesi parazit (Strongyloides) dışlanmasını her seferinde teyit et; immünsüpresyon güvenliğini gözet
- EoE kroniktir: tedaviyi kesince nüks beklenir — aileyi idame gereği ve uzun süreli izlem konusunda bilgilendir
- Striktür/dar lümen gelişiminde dilatasyon + medikal tedavi; fibrozisi önlemek için inflamasyonu remisyonda tut
- Aileye yazılı uyarı: katı besin takılması/impaksiyon, ilerleyici disfaji, kilo kaybı, kanama, ödem, ateş-döküntü-LAP gelişiminde erken başvuru
- Diyetisyen ve gerekirse alerji ile multidisipliner yönetim; atopik komorbiditelerin (astım, rinit, egzama) eş yönetimi

- Geçiş bakımı: adölesandan erişkin gastroenteroloji izlemine yapılandırılmış devir; uyum ve yaşam kalitesi odaklı takip

En iyi sonuç; eozinofiliyi primer/sekonder ekseninde doğru ayırmak, GİS semptomlu çocukta yeterli çok düzeyli biyopsiyle EoE/EGID'yi eşiklerle tanımlamak, seçilen tedavi kolunda remisyonu kontrol biyopsisiyle belgelemek, kronik hastalıkta idameyi ve büyümeyi izlemek ve sistemik/tehlikeli nedenleri (HES, malignite, immün yetmezlik, dissemine parazit) atlamayan bir güvenlik ağıyla elde edilir.

Kaynaklar

1. Dellon ES, Liacouras CA, Molina-Infante J, et al. Updated International Consensus Diagnostic Criteria for Eosinophilic Esophagitis: Proceedings of the AGREE Conference. Gastroenterology. 2018;155(4):1022-1033.
2. Hirano I, Chan ES, Rank MA, et al. AGA Institute and the Joint Task Force on Allergy-Immunology Practice Parameters Clinical Guidelines for the Management of Eosinophilic Esophagitis. Gastroenterology. 2020;158(6):1776-1786.
3. Papadopoulou A, Amil-Dias J, Auth MKH, et al. Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines on Childhood Eosinophilic Gastrointestinal Disorders Beyond Eosinophilic Esophagitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024;78(1):122-152.
4. Shomron N, Valent P, Klion AD, et al. Contemporary Consensus on the Definition and Classification of Hypereosinophilic Syndromes and Eosinophilia. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(3):607-612.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Histolojik eozinofil eşikleri örnekleme, alan sayımı ve kit/laboratuvar yöntemine; dozlar hastaya, ağırlığa, yaşa, organ fonksiyonlarına ve tedavi yanıtına göre teyit edilmelidir. Sistemik/yutulan steroide başlamadan önce parazit (Strongyloides) dışlanmalıdır.